

Avaliação das Unidades Básicas de Saúde no contexto das RAS e do MACC

Questionário para as Unidades de Atenção Primária (UAPs)

Todas as perguntas deste questionário são de preenchimento obrigatório.

Ao enviar este formulário, seus dados pessoais (nome, e-mail etc.) não são coletados automaticamente, exceto quando informados voluntariamente.

Sumário

Seção 1 — IDENTIFICAÇÃO (Q1–Q6)

Seção 2 — TERRITORIALIZAÇÃO E CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO (Q7–Q26)

Seção 3 — CADASTRO E IDENTIFICAÇÃO DE SUBPOPULAÇÕES (Q27–Q37)

Seção 4 — ACESSO DE PRIMEIRO CONTATO (Q38–Q48)

Seção 5 — ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO (Q49–Q64)

Seção 6 — COORDENAÇÃO DO CUIDADO E INTEGRAÇÃO DA REDE (Q65–Q74)

Seção 7 — ATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES CRÔNICAS (Q86–Q95)

Seção 8 — REDE DE ATENÇÃO MATERNO-INFANTIL (Q96–Q119)

Seção 9 — GOVERNANÇA, APOIO INSTITUCIONAL E MONITORAMENTO PELO NÍVEL CENTRAL (Q120–Q143)

Seção 10 — AVALIAÇÃO GERAL (Q144–Q158)

SEÇÃO 1

IDENTIFICAÇÃO

1. Nome da unidade:

2. Área Programática

3. CNES:

4. Telefone para contato:

5. Respondente:

6. Função:

SEÇÃO 2

TERRITORIALIZAÇÃO E CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO

7. A unidade possui território de abrangência formalmente definido?

☐ Sim ☐ Não

8. A unidade possui mapa atualizado de seu território e respectivas microáreas?

☐ Sim ☐ Não

9. Qual o número estimado da população adscrita à unidade?

10. A unidade dispõe de diagnóstico situacional atualizado do território?

☐ Sim ☐ Não

11. O diagnóstico situacional contempla:

12. Com que frequência a unidade realiza a análise das necessidades de saúde do território?

☐ Nunca ☐ Mensalmente ☐ Trimestralmente ☐ Semestralmente ☐ Anualmente
☐ Outra

13. Quais são os principais problemas de saúde identificados no território?

14. Com que frequência a unidade identifica áreas ou grupos populacionais de maior vulnerabilidade?

☐ Nunca ☐ Mensalmente ☐ Trimestralmente ☐ Semestralmente ☐ Anualmente
☐ Outra

15. Quais são as principais dificuldades para manter o cadastro territorial atualizado?

16. Como as informações do território são utilizadas no planejamento das ações da unidade?

17. A unidade utiliza informações territoriais para definir prioridades assistenciais?

☐ Sim ☐ Não ☐ Ocasionalmente

18. A unidade possui cobertura por Agentes Comunitários de Saúde (ACS) em todo o território adscrito?

☐ Sim ☐ Não

19. Todas as equipes possuem ACS vinculados?

☐ Sim ☐ Não

20. Existe microárea formalmente definida para cada ACS?

☐ Sim ☐ Não

21. Quais dificuldades os ACS enfrentam para realizar visitas domiciliares?

22. Os ACS utilizam dispositivos eletrônicos para o cadastro territorial?

☐ Sim ☐ Não ☐ Às vezes

23. Os ACS recebem capacitação para a utilização dos sistemas de informação?

☐ Sim ☐ Não ☐ Às vezes

24. A unidade utiliza os dados coletados pelos ACS para planejamento das ações de saúde?

☐ Sempre ☐ Frequentemente ☐ Raramente ☐ Nunca

25. De que forma as informações produzidas pelos ACS são utilizadas no planejamento das ações da unidade?

26. Os ACS participam das reuniões de equipe?

☐ Sempre ☐ Frequentemente ☐ Ocasionalmente ☐ Nunca

SEÇÃO 3

CADASTRO E IDENTIFICAÇÃO DE SUBPOPULAÇÕES

27. Qual o número de usuários cadastrados na unidade?

28. Qual o número de usuários com cadastro ativo na unidade?

29. Com que frequência o cadastro do usuário é atualizado?

☐ Nunca ☐ A cada visita ☐ Quinzenalmente ☐ Mensalmente ☐
Semestralmente ☐ Anualmente ☐ Outra

30. Como ocorre essa atualização cadastral?

31. A unidade monitora a proporção de cadastros desatualizados?

☐ Sim ☐ Não ☐ Às vezes

32. Como esse monitoramento é feito?

33. A unidade identifica subpopulações prioritárias no território?

☐ Sim ☐ Não ☐ Às vezes

34. A unidade mantém cadastro nominal atualizado dos seguintes grupos:

35. A unidade utiliza o cadastro para busca ativa de usuários?

☐ Sim ☐ Não ☐ Às vezes

36. Como essa busca é feita?

37. Como são identificadas e atualizadas as subpopulações prioritárias?

SEÇÃO 4

ACESSO DE PRIMEIRO CONTATO

38. A unidade atua como principal porta de entrada dos usuários para a rede de saúde?

☐ Sim ☐ Não

39. Detalhe:

40. Existe acolhimento da demanda espontânea durante todo o horário de funcionamento?

☐ Sim ☐ Não

41. Descreva.

42. O usuário pode agendar consultas sem necessidade de comparecimento prévio à unidade?

☐ Sim ☐ Não

43. Descreva.

44. Existem critérios formalizados para classificação e priorização dos atendimentos?

☐ Sim ☐ Não

45. Descreva.

46. Qual o tempo médio (em dias) para consulta médica programada?

47. Qual o tempo médio (em dias) para consulta de enfermagem programada?

48. Quais são as principais dificuldades relacionadas ao acesso dos usuários?

SEÇÃO 5

ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO

49. A unidade realiza estratificação de risco para pessoas com condições crônicas?

☐ Sim ☐ Não ☐ Às vezes

50. Descreva.

51. A estratificação segue protocolo institucional formalizado?

☐ Sim ☐ Não ☐ Às vezes

52. Descreva.

53. A estratificação é registrada em sistema informatizado?

☐ Sim ☐ Não ☐ Às vezes

54. Descreva.

55. Quais condições são submetidas à estratificação de risco?

56. A unidade consegue informar o quantitativo de usuários por estrato de risco?

☐ Sim ☐ Não

57. A frequência de acompanhamento varia conforme o estrato de risco?

☐ Sim ☐ Não

58. Há plano de cuidado diferenciado para usuários de alto risco?

☐ Sim ☐ Não

59. Descreva.

60. Os usuários de alto risco recebem monitoramento específico?

☐ Sim ☐ Não ☐ Às vezes

61. Descreva.

62. Com que frequência estratificação é revisada?

☐ Semestralmente ☐ Anualmente ☐ Conforme necessidade clínica ☐ Não há revisão
periódica ☐ Outra

63. Descreva.

64. Descreva como a estratificação é utilizada no planejamento assistencial.

SEÇÃO 6

COORDENAÇÃO DO CUIDADO E INTEGRAÇÃO DA REDE

65. A unidade acompanha os usuários encaminhados para outros pontos da rede?

☐ Sim ☐ Não ☐ Às vezes

66. Descreva.

67. Existe fluxo formal de referência e contrarreferência?

☐ Sim ☐ Não

68. Descreva.

69. A unidade recebe regularmente informações dos serviços especializados sobre os usuários encaminhados?

☐ Sempre ☐ Frequentemente ☐ Ocasionalmente ☐ Nunca

70. Como essa comunicação é feita?

71. Como é realizado o acompanhamento dos usuários encaminhados para outros serviços?

72. A equipe realiza discussão periódica de casos complexos?

☐ Sim ☐ Não

73. Existem profissionais responsáveis pelo monitoramento de usuários de maior risco?

☐ Sim ☐ Não ☐ Às vezes

74. Descreva.

SEÇÃO 7

ATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES CRÔNICAS

86. A unidade possui protocolos clínicos formalizados para condições crônicas prioritárias?

☐ Sim ☐ Não

87. Descreva.

88. Os usuários com maior risco clínico recebem acompanhamento diferenciado?

☐ Sim ☐ Não ☐ Às vezes

89. Descreva.

90. A unidade desenvolve ações de autocuidado apoiado?

☐ Sim ☐ Não ☐ Às vezes

91. Descreva.

92. Há monitoramento sistemático dos pacientes com condições crônicas?

☐ Sim ☐ Não

93. Descreva.

94. Descreva as principais estratégias adotadas para gestão das condições crônicas.

95. Existe acompanhamento programado para pessoas com:

SEÇÃO 8

REDE DE ATENÇÃO MATERNO-INFANTIL

96. Com que frequência os ACS realizam busca ativa de gestantes?

☐ Nunca ☐ Diariamente ☐ Semanalmente ☐ Quinzenalmente ☐ Mensalmente
☐ Outra

97. Como os ACS contribuem para a identificação precoce das gestantes no território?

98. Todas as gestantes cadastradas estão vinculadas a uma maternidade de referência?

☐ Sim ☐ Não ☐ Às vezes

99. A unidade mantém lista nominal atualizada das gestantes acompanhadas?

☐ Sim ☐ Não

100. Existe monitoramento das faltas às consultas de pré-natal?

☐ Sim ☐ Não ☐ Às vezes

101. Há busca ativa de gestantes faltosas?

☐ Sim ☐ Não ☐ Às vezes

102. Com que frequência os ACS realizam busca ativa de gestantes com pré-natal interrompido?

☐ Nunca ☐ Diariamente ☐ Semanalmente ☐ Quinzenalmente ☐ Mensalmente
☐ Outra

103. Como ocorre o acompanhamento de gestantes faltosas ou que abandonam o pré-natal?

104. A unidade acompanha a realização dos exames preconizados para o pré-natal?

☐ Sim ☐ Não ☐ Às vezes

105. Existe processo de estratificação de risco das gestantes cadastradas no território?

☐ Sim ☐ Não ☐ Às vezes

106. Descreva.

107. Os ACS participam da identificação de gestantes de risco?

☐ Sempre ☐ Frequentemente ☐ Ocasionalmente ☐ Nunca

108. Os ACS recebem capacitação sobre estratificação de riscos?

☐ Sim ☐ Não ☐ Às vezes

109. Existe fluxo formal para encaminhamento de gestantes de alto risco?

☐ Sim ☐ Não

110. Há retorno de informações da maternidade para a unidade após o parto?

☐ Sim ☐ Não ☐ Às vezes

111. A unidade acompanha a puérpera e o recém-nascido após a alta hospitalar?

☐ Sim ☐ Não ☐ Às vezes

112. Como ocorre o acompanhamento de recém-nascidos e crianças de risco no território?

113. Com que frequência os ACS realizam busca ativa de crianças faltosas às consultas de puericultura?

☐ Nunca ☐ Diariamente ☐ Semanalmente ☐ Quinzenalmente ☐ Mensalmente
☐ Outra

114. Descreva.

115. Como ocorre a comunicação entre a unidade e os demais serviços da Rede Materno-Infantil?

116. Os ACS recebem capacitação periódica para atuação na saúde materno-infantil?

☐ Sim ☐ Não ☐ Às vezes

117. Descreva.

118. Quais melhorias poderiam fortalecer a atuação dos ACS na coordenação do cuidado materno-infantil?

119. Qual o percentual estimado do território adscrito à UBS coberto por Agentes Comunitários de Saúde (ACS)?

☐ 0% a 30% ☐ 31% a 50% ☐ 51% a 60% ☐ 61% a 70% ☐ 71% a 80% ☐ 81% a 100%

SEÇÃO 9

GOVERNANÇA, APOIO INSTITUCIONAL E MONITORAMENTO PELO NÍVEL CENTRAL

120. O nível central estabelece metas assistenciais para a unidade?

☐ Sim ☐ Não ☐ Às vezes

121. Descreva.

122. As metas são formalmente pactuadas com a equipe local?

☐ Sim ☐ Não ☐ Às vezes

123. Descreva.

124. O cumprimento das metas é monitorado periodicamente?

☐ Sim ☐ Não ☐ Às vezes

125. A unidade recebe devolutiva sobre o cumprimento das metas?

☐ Sim ☐ Não ☐ Às vezes

126. Como ocorre a devolutiva dos resultados para a equipe da unidade?

127. O nível central realiza reuniões periódicas para análise de resultados com a equipe da unidade?

☐ Sim ☐ Não ☐ Às vezes

128. Descreva.

129. A unidade recebe regularmente informações sobre seu desempenho assistencial?

☐ Sim ☐ Não ☐ Às vezes

130. A unidade recebe apoio institucional para melhoria dos indicadores?

☐ Sim ☐ Não ☐ Às vezes

131. Descreva.

132. O nível central utiliza os resultados dos indicadores para redefinir prioridades e apoiar a organização da assistência?

☐ Sim ☐ Não ☐ Às vezes

133. Descreva.

134. Existe painel de indicadores disponibilizado à unidade?

☐ Sim ☐ Não

135. Quais indicadores são mais frequentemente acompanhados pelo nível central?

136. O nível central apoia a implementação de protocolos clínicos?

☐ Sim ☐ Não

137. Descreva.

138. O nível central apoia a estratificação de risco e a gestão de casos complexos?

☐ Sim ☐ Não

139. Descreva.

140. O nível central promove ações de educação permanente para as equipes?

☐ Sim ☐ Não

141. Que tipos de capacitação ou educação permanente são promovidos para a equipe?

142. Quais formas de apoio institucional são oferecidas pelo nível central?

143. Na percepção da equipe, quais aspectos do apoio do nível central poderiam ser aprimorados?

SEÇÃO 10

AVALIAÇÃO GERAL

144. Quais são as principais fortalezas da unidade na coordenação do cuidado da população adscrita?

145. Quais são as principais dificuldades para atuação da unidade como coordenadora da Rede de Atenção à Saúde?

146. Quais melhorias a equipe considera prioritárias para aprimorar o funcionamento da rede?

147. Avalie na escala de 1 a 5, sendo 1 a pior nota e 5 a melhor nota, considerando critérios de tempo adequado para atendimento de pacientes, em relação a consultas com médicos especialistas.

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

148. Esclareça sua nota.

149. Avalie na escala de 1 a 5, sendo 1 a pior nota e 5 a melhor nota, considerando critérios de tempo adequado para atendimento de pacientes, em relação a realização de exames médicos.

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

150. Esclareça sua nota.

151. Avalie na escala de 1 a 5, sendo 1 a pior nota e 5 a melhor nota, considerando critérios de prestação adequada do serviço de saúde, em relação a recursos humanos da unidade.

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

152. Esclareça a resposta.

153. Avalie na escala de 1 a 5, sendo 1 a pior nota e 5 a melhor nota, considerando critérios de prestação adequada do serviço de saúde, em relação a estrutura, materiais e equipamentos da unidade.

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

154. Esclareça a resposta.

155. A UBS possui equipes de saúde da família incompletas?

☐ Sim ☐ Não

156. Durante o ano corrente, foi comum haver áreas sem equipes completas?

☐ Sim ☐ Não

157. Esclareça a resposta anterior.

158. Sobre a manutenção de equipes de ESF completas, quais são os desafios enfrentados? Quais os profissionais de maior carência na unidade?